

TEMA 6.20 • INFECTOLOGÍA

Infecciones Oportunistas

PERFIL EUNACOM 1.05.1.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Infecciones Oportunistas en VIH/SIDA

Comparativa Clínica y Diagnóstica

TABLA 6.20.1: AGENTE VS CLÍNICA CARACTERÍSTICA			
AGENTE	CLÍNICA CARACTERÍSTICA	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
Candida (oral/genital)	Muguet (placas blancas), balanitis, leucorrea grumosa	Clínico	Fluconazol 150 mg 1 dosis
Candida esofágica	Disfagia + odinofagia	Prueba terapéutica con fluconazol (si no mejora en 3 días → EDA)	Fluconazol 200 días
Pneumocystis jirovecii (PCP)	Neumonía subaguda (semanas) bilateral, LDH muy elevada	PCR o Inmunofluorescencia directa	Cotrimoxazol (+ corticoides si PO ₂ < 70)
Toxoplasma gondii	Absceso cerebral: signos focales, convulsiones	TAC con contraste → lesión con realce en anillo	Sulfadiazina + Pirimetamina
Cryptococcus	Meningitis (menínea: rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski)	PL → LCR con tinta china: levaduras capsuladas + glucosa baja + mononuclear	Anfotericina B liposomal
CMV	Coriorretinitis (↓ agudeza visual) ± colitis, esofagitis, adenitis	Fondo de ojo	Ganciclovir / Valganciclovir
MAC (M. avium complex)	Sepsis subaguda/crónica, baja de peso, fiebre sin foco claro	PCR para micobacterias atípicas	Claritromicina / Etambutol / Rifabutin
Criptosporidium	Diarrea acuosa crónica	Parasitológico especial	Solo TARV (si ATB eficaz)
Isospora	Diarrea acuosa crónica	Parasitológico especial	Cotrimoxazol
Microsporidium	Diarrea acuosa crónica	Parasitológico especial	Albendazol
Sarcoma de Kaposi	Nódulos violáceos/eritematosos en piel	Biopsia (para diferenciar de Angiomatosis Bacilar = Bartonella)	TARV + Químio/Radio/Cirugía
LMP (Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva)	Signos focales + demencia progresiva	RMN cerebro: lesiones desmielinizantes múltiples en sustancia blanca	Solo TARV (no hay tratamiento específico para VJC)

EUNACOM CRITERIOS

Reglas de oro VIH: - PCP → LDH elevada + neumonía bilateral subaguda - Toxoplasma → Lesión cerebral en anillo en TAC - Criptococo → Meningitis en VIH - CMV → ↓ visión en VIH - MAC → Sepsis insidiosa con CD4 < 50 - Criptosporidiosis vs Criptococosis No confundir (parásito intestinal vs hongo meníngeo)

Familia Herpesviridae (Resumen)

NÚMERO	NOMBRE	ENFERMEDAD
HHV-1	Herpes simplex 1	Herpes bucal, encefalitis herpética
HHV-2	Herpes simplex 2	Herpes genital
HHV-3	VVZ	Varicela + Herpes zóster
HHV-4	VEB	Mononucleosis
HHV-5	CMV	Coriorretinitis (VIH), TORCH
HHV-6/7	—	Exantema súbito (roseóla) en lactantes

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente VIH positivo con CD4 de 150/mm³ consulta por disfagia de 2 semanas de evolución. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infecciones Oportunistas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Candidiasis esofágica: disfagia en VIH, fluconazol 21 días. Primero prueba terapéutica, endoscopia solo si no mejora en 3 días.
- Pneumocystis jirovecii: más frecuente definitiva de SIDA. Neumonía arrastrada bilateral, LDH alta, infiltrado intersticial difuso. PCR o inmunofluorescencia. Cotrimoxazol + corticoides si PaO₂<70.
- Toxoplasma: signos focales + convulsiones en VIH. TAC: captación en anillo. Sulfadiazina + pirimetamina.
- Criptococo: meningoencefalitis con signos meníngeos. Tinta china en LCR (levadura capsulada). Anfotericina liposomal.
- CMV: coriorretinitis (baja agudeza visual, fondo de ojo), colitis, adenitis. Ganciclovir/foscarnet.
- No confundir: criptococo (meningitis) vs criptosporidium (diarrea). Sarcoma de Kaposi (herpes 8) vs angiomatosis bacilar (Bartonella) = biopsia.
- Neumonía más frecuente en VIH: neumococo (no Pneumocystis). Causa más frecuente de convulsiones en VIH: toxoplasma.
- Leucoencefalopatía multifocal (virus JC): demencia + lesiones sustancia blanca en RMN. Solo tratamiento con triterapia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIONES OPORTUNISTAS)

PREGUNTA 1

Paciente VIH positivo con CD4 de 150/mm³ consulta por disfagia de 2 semanas de evolución. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Endoscopia digestiva alta inmediata
- ☐ B) Iniciar fluconazol por 21 días como prueba terapéutica
- ☐ C) Solicitar cultivo faríngeo para Candida
- ☐ D) Iniciar ganciclovir por sospecha de esofagitis por CMV
- ☐ E) Aciclovir oral por sospecha de esofagitis herpética

PREGUNTA 2

Hombre de 32 años con baja de peso de un año y promiscuidad sexual presenta neumonía bilateral de 3 semanas de evolución, con infiltrado intersticial difuso en radiografía y LDH de 850 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- ☐ A) Neumonía por neumococo; ceftriaxona
- ☐ B) Neumonía por Pneumocystis jirovecii; cotrimoxazol
- ☐ C) Tuberculosis pulmonar; esquema RIPE
- ☐ D) Neumonía por Mycoplasma; azitromicina
- ☐ E) Neumonía por CMV; ganciclovir

PREGUNTA 3

Paciente VIH con CD4 de 60/mm³ presenta hemiparesia derecha y convulsión tónico-clónica focal. El TAC con contraste muestra lesión frontal izquierda que capta contraste en anillo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Meningoencefalitis por criptococo
- ☐ B) Leucomalacia multifocal progresiva
- ☐ C) Toxoplasmosis cerebral
- ☐ D) Neumonía por Pneumocystis con compromiso neurológico
- ☐ E) Linfoma primario del SNC

RESUMEN: INFECCIONES OPORTUNISTAS

Esta clase revisa las infecciones oportunistas del VIH. La candidiasis oral (algorra) y genital son etapa B; la candidiasis esofágica es definitiva de SIDA (etapa C), se presenta con disfagia, se trata con fluconazol 21 días y ante sospecha se hace prueba terapéutica antes de endoscopia. Pneumocystis jirovecii es la infección definitiva de SIDA más frecuente. Produce neumonía bilateral de curso arrastrado (semanas), con LDH muy elevada e infiltrado intersticial bilateral difuso en radiografía. Diagnóstico con PCR o inmunofluorescencia directa. Tratamiento con cotrimoxazol; agregar corticoides si PaO₂ <70 mmHg. Toxoplasma gondii (segunda más frecuente) produce encefalitis focal con signos focales, convulsiones parciales. TAC con contraste muestra lesión que capta en anillo. Tratamiento con sulfadiazina + pirimetamina. Cryptococcus produce meningoencefalitis (signos meníngeos, rigidez de nuca). Diagnóstico con punción lumbar y tinción con tinta china (levadura capsulada). Tratamiento con anfotericina liposomal. Citomegalovirus produce coriorretinitis (disminución de agudeza visual, diagnóstico con fondo de ojo), colitis, adenitis. Tratamiento con ganciclovir o foscarnet. Mycobacterium avium complex produce sepsis subaguda insidiosa, diagnóstico con PCR. Criptosporidium, isospora y microsporidium producen diarrea crónica acuosa. Sarcoma de Kaposi (virus herpes 8) produce nódulos eritematovioláceos, diagnóstico con biopsia (diferenciar de angiomatosis bacilar). Leucomalacia multifocal progresiva (virus JC) produce signos focales y demencia, lesiones de sustancia blanca en RMN, solo tratamiento con triterapia.